

模擬考卷・詳解版

Mock Exam・Answer Key

2026 年版・第一版

AI-assisted

病理科模擬考卷詳解版（最新兩次考題 50 題）

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生・答案以官方為準；機轉與教學延伸為 AI 整理，可能有誤，請對照 Robbins / WHO 查證

答案逐題詳解 + 機轉解釋 + 教學重點 + 干擾選項拆解。建議教學時逐題帶過。

答案總覽

題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案	題號	答案
Q1	D	Q11	A	Q21	A	Q31	A	Q41	B
Q2	A	Q12	B	Q22	A	Q32	D	Q42	D
Q3	D	Q13	C	Q23	B	Q33	A	Q43	D
Q4	B	Q14	C	Q24	D	Q34	C	Q44	B
Q5	C	Q15	D	Q25	A	Q35	D	Q45	B
Q6	A	Q16	B	Q26	B	Q36	D	Q46	B
Q7	A	Q17	A	Q27	A	Q37	A	Q47	A
Q8	C	Q18	C	Q28	A	Q38	B	Q48	A
Q9	C	Q19	A	Q29	C	Q39	D	Q49	A
Q10	D	Q20	A	Q30	C	Q40	D	Q50	C

Q11 (鼻咽癌題) 官方答案為「#」(送分題)，但學理上 A 是錯誤敘述 (鼻咽癌與 EBV 相關，非 HPV)。

Part 1 — 114 年第 2 次詳解

Q1 (答 D) coagulative necrosis 顯微特徵

- **核心知識**：凝固性壞死 = 細胞質強烈嗜酸性紅染、核淡化或消失 (karyolysis)，但細胞結構輪廓 ghost-like 仍可辨認
- **干擾選項拆解**：
 - (A) 液化性壞死 → 腦梗塞、化膿，整片融解
 - (B) 乾酪性壞死 → 結核中央，似 cheese 碎屑，無細胞結構
 - (C) 纖維素樣壞死 → 血管壁，PAS+ 強嗜酸帶
- **教學延伸**：心肌梗塞為典型 coagulative；脾、腎、心、肝 ischemic infarct 皆為 coagulative

Q2 (答 A) 不可逆細胞傷害標誌

- 核心知識：粒線體膜通透性轉換孔 (mPTP) 開啟 → 粒線體蛋白 (cytochrome c) 外漏 = 不可逆 point of no return
- 干擾選項：(B)(C)(D) 都是「可逆」傷害的早期變化
- 教學延伸：可逆 vs 不可逆的三大分水嶺：① 嚴重粒線體破壞 ② 細胞膜廣泛缺損 ③ DNA 與核蛋白溶解
- 臨床應用：troponin 升高 = 心肌已進入不可逆，因為它是粒線體釋出物

Q3 (答 D) Marfan syndrome

- 核心知識：Fibrillin-1 (FBN1) 突變，體染色體顯性遺傳，身材高瘦 (非矮小)，主動脈根部擴大 → 主動脈剝離
- 錯誤選項解構：
 - (A) 不是 collagen → 是 fibrillin-1 (彈性蛋白支架)
 - (B) 不是隱性 → 是顯性
 - (C) 不是矮小 → 是高瘦、長指
- 重要對比：Ehlers-Danlos = collagen 異常，Osteogenesis imperfecta = collagen I 異常
- 教學重點：「主動脈剝離 + 高瘦」=Marfan

Q4 (答 B) Pemphigus vulgaris

- 核心知識：抗 desmoglein 3/1 IgG → Type II 過敏反應 (抗體對抗細胞表面抗原)
- DIF 影像：表皮內網狀魚網樣 (fish-net) 沉積
- 臨床特徵：脆弱性鬆弛大水皰、Nikolsky sign 陽性
- 對比：Bullous pemphigoid → anti-BP180/230，基底膜帶線狀沉積，仍屬 Type II 但水皰較紮實
- 治療：類固醇 + Rituximab (抗 CD20)

Q5 (答 C) 慢性 CO 中毒

- 核心知識：慢性低劑量 CO → basal ganglia (特別是 globus pallidus) 對缺氧最敏感 → 雙側對稱性壞死
- 急性高劑量 CO：cherry red 皮膚顏色 + 廣泛大腦皮質損傷
- 延伸：缺氧最易壞死的部位序列 = 海馬 CA1 (pyramidal) > Purkinje 細胞 > 大腦第 3、5、6 層皮質 > basal ganglia

Q6 (答 A) 惡性腫瘤最不可靠特徵

- 核心知識：生長快速不可靠 — 良性也可能快速生長 (如妊娠中乳腺纖維腺瘤)；惡性也可能緩慢
- 最可靠 = (D) 轉移 (pathognomonic for malignancy)
- 教學重點：四大可靠惡性特徵 = ① 轉移 ② 侵犯 ③ 嚴重 atypia + 異常 mitosis ④ 失分化

Q7 (答 A) 先天心臟病與肺高壓

- 核心知識：左向右分流 (VSD、ASD、PDA) → 肺血流增加 → 久了肺血管阻塞性病變 → 肺高壓 → **Eisenmenger** 反轉
- 干擾選項：
 - (B) Fallot 是右向左 → 肺血流減少，無肺高壓
 - (C) Coarctation → 上肢高血壓不是肺高壓
 - (D) Isolated PS → 右心室代償，肺壓不升
- 教學延伸：肺血管病變六階段 (Heath-Edwards classification)

Q8 (答 C) 非血小板缺陷的凝血異常

- 核心知識：
 - (A) vWD → vWF 缺，影響血小板黏附 (也算血小板功能)
 - (B) 尿毒症 → 血小板功能異常
 - (D) Aspirin → 抑制 COX → 血小板功能異常
 - (C) Hemophilia = Factor VIII/IX 缺失 (凝固因子，非血小板)
- 教學延伸：BT vs aPTT 鑑別出血傾向
 - BT 延長 = 血小板異常或 vWD
 - aPTT 延長 = 內生路徑 (Hemophilia)
 - PT 延長 = 外生路徑 (VII 缺、warfarin)

Q9 (答 C) Hodgkin lymphoma 腫瘤細胞稀少

- 核心知識：Hodgkin lymphoma 中真正的腫瘤細胞 **Reed-Sternberg** 細胞只佔少數 (< 5%)，其餘為反應性發炎細胞 (lymphocyte、eosinophil、plasma cell、neutrophil)
- RS 細胞：CD15+、CD30+、CD45-、PAX5 弱+，雙葉核「貓頭鷹眼」
- 對比：DLBCL、Burkitt、ALCL 腫瘤細胞 = 主體

Q10 (答 D) 骨髓造血細胞最少

- 核心知識：Aplastic anemia = 骨髓空蕩、被脂肪取代
- 其他三者骨髓 cellular ↑：
 - IDA → erythroid hyperplasia
 - Megaloblastic → 巨母紅血球性 hyperplasia
 - Thalassemia → 嚴重 erythroid hyperplasia (骨髓擴張 → crew-cut skull)

Q11 (答 A，官方送分) 鼻咽癌

- 學理正確答案 = A：鼻咽癌與 **EBV** 相關，非 HPV
- 但因爭議性 (南方型 keratinizing 偶爾與 HPV 相關)，官方判送分
- 教學重點：鼻咽癌「三大特徵」= ① EBV ② 南亞/南中國高發 ③ 頸部淋巴結轉移先表現
- 染色：EBER ISH 是診斷標配

Q12 (答 B) 小細胞肺癌錯誤敘述

- 核心知識：SCLC 幾乎不帶 EGFR 突變 (EGFR 是腺癌亞洲女性非吸菸者的特徵)
- SCLC 分子特徵 = TP53 + RB 雙失活 (>90%)
- SCLC 副腫瘤：SIADH、Cushing (ACTH 分泌)、Lambert-Eaton

Q13 (答 C) 矽肺病錯誤敘述

- 核心知識：矽肺病肺纖維化不可逆，停止暴露後不會恢復，嚴重者需肺移植
- 矽肺三大特徵：① 上肺葉 nodule ② whorled collagen ③ 偏光下 birefringent silica 粒
- 重要併發症：矽肺 → 結核易感 (silicotuberculosis)

Q14 (答 C) 口腔癌錯誤敘述

- 核心知識：口腔 SCC 雖有 TP53/CDKN2A/PIK3CA 突變，但目前並無有效靶向藥 (這些都是 tumor suppressor、難以針對)
- 治療仍以手術 + 放化療為主，免疫療法 (pembrolizumab) 為近年新增
- 教學重點：頭頸 SCC 與肺腺癌「分子相似但治療路徑不同」

Q15 (答 D) HNF1α-inactivated HCA

- 核心知識：HNF1α 失活 → LFABP 表現喪失 (題目反過來說 = 錯)
- HCA 四大分子分型 (重要！)：

分型	標記	風險
HNF1α inactivated	LFABP 失	極低惡變
Inflammatory	SAA、CRP+	中等惡變
β-catenin activated	nuclear β-catenin、GS 瀰漫+	高惡變
Unclassified	—	不定

- 臨床：MODY-3 患者多型；好發於女性 (口服避孕藥相關)

Q16 (答 B) 急性膽囊炎錯誤敘述

- 正確機轉：阻塞 → 黏膜傷害 → 釋出前列腺素 → 發炎 (題目說「減少」是錯的)
- 90% 結石性，10% 非結石性 (與敗血症、創傷、TPN、缺血有關)
- 教學延伸：膽石症 5F = Female、Fat、Forty、Fertile、Fair

Q17 (答 A) Renal oncocytoma

- 核心知識：胞質充滿粒線體 → 嗜酸性
- 形態：mahogany brown 顏色 (肉眼)、central scar (影像)、neoplasm cell 巢狀
- 重要鑑別：vs Chromophobe RCC (也嗜酸)
 - Oncocytoma 是良性
 - Chromophobe RCC 含 microvesicle (PAS+)，plant-cell-like 細胞膜

Q18 (答 C) Xanthogranulomatous pyelonephritis

- 核心知識：Proteus mirabilis (urea splitting → struvite stone → 反覆感染)
- 形態：黃色泡沫巨噬細胞 (lipid-laden macrophages) 瀰漫
- 臨床：女性多、結石、糖尿病
- 腫瘤偽裝：常被誤以為 RCC (術前難鑑別)

Q19 (答 A) 腎細胞癌最大危險因子

- 核心知識：抽菸是首位 (其次 HTN、肥胖、慢性腎病、VHL)
- 石綿 → mesothelioma、肺癌 (非 RCC)
- 教學延伸：clear cell RCC 與 VHL 基因 3p25 缺失相關

Q20 (答 A) 放射線治療後乳房肉瘤

- 核心知識：放射後最常見的二次惡性 = angiosarcoma (潛伏期 5-10 年)
- 表現：紫紅斑塊、結節
- IHC：CD31、CD34、ERG (內皮標記) +

Q21 (答 A) 乳房 ALH 風險

- 核心知識：Atypical lobular hyperplasia → 雙側乳癌風險 × 4-5 倍
- 比 sclerosing adenosis、complex sclerosing lesion 高
- 臨床處置：診斷後密切追蹤 + 考慮 tamoxifen 預防

Q22 (答 A) 子宮頸 HSIL

- 核心知識：基底層 2/3 以上 atypia = HSIL (CIN II-III)
- 對比：LSIL = 下 1/3 + koilocyte (HPV cytopathic effect)
- 進展風險：HSIL → invasive Ca 約 30%

Q23 (答 B) 蝕骨細胞活性異常

- 核心知識：
 - ① Osteopetrosis = osteoclast 不能 resorb (mutation in CA II 等)
 - ③ Post-menopausal osteoporosis = 雌激素 ↓ → osteoclast 過度活化
 - ⑤ Paget disease = osteoclast 異常巨大過度活化 + osteoblast 失調
 - ② Senile osteoporosis = osteoblast 老化 → 屬 osteoblast 問題
 - ④ Osteomalacia = vitamin D 缺乏 → 骨基質礦化不足，與 osteoclast 無關

Q24 (答 D) 皮膚培養出致病菌

- 核心知識：Erythema migrans = Lyme disease · Borrelia burgdorferi 可在病灶處培養
- 其他 erythema 多為免疫反應性 (無活菌)：

- EM → drug、HSV 反應
- Erythema induratum → 結核反應 (panniculitis)
- Erythema nodosum → 結核、Strep、藥物、IBD 反應

Q25 (答 A) 感染性關節炎錯誤敘述

- 核心知識：兩歲以下幼兒最常見化膿性關節炎 = **Staphylococcus aureus**
 - Salmonella 在鐮形細胞病患者特別好發 (不是 default)
- 年齡分層：
 - 新生兒：S. aureus、GBS、Gram(-) bacilli
 - < 2 歲：S. aureus、H. influenzae (疫苗後減少)
 - 青少年：**Neisseria gonorrhoeae**
 - 成人：S. aureus

Part 2 — 115 年第 1 次詳解

Q26 (答 B) Phosphatidylserine 外翻

- 核心知識：細胞凋亡早期，flippase 失活 → PS 從內層翻到外層 → "eat me" 信號 → 巨噬細胞吞噬
- 臨床應用：Annexin V 染色 (PS-binding) = 早期凋亡偵測
- 延伸：對比細胞凋亡 vs 壞死的吞噬機制 (凋亡無發炎；壞死有發炎)

Q27 (答 A) 生理性肥大主要路徑

- 核心知識：PI3K/AKT/mTOR = 生理性肥大 (運動員心臟、孕婦子宮)
- 對比病理性肥大 (壓力負荷高血壓心臟) = GPCR 活化、Ca⁺⁺/calcineurin/NFAT
- 延伸：PIK3CA 突變 → 腫瘤性 PI3K 過度活化 → Alpelisib 為標靶

Q28 (答 A) 病毒-疾病錯誤配對

- 正確：Hairy leukoplakia = EBV (HIV 患者)
- HPV → 條狀疣、口腔 papilloma、SCC
- 其他三個都正確：HHV-8/PEL、EBV/NK-T、JCV/PML
- 教學重點：免疫缺陷者「病毒-腫瘤」清單

Q29 (答 C) 腎臟移植排斥分類

- 核心知識：

排斥類型	時程	主要病理	治療
Hyperacute	分鐘-小時	預存抗體 → 血栓	切除腎臟

排斥類型	時程	主要病理	治療
Acute cellular	天-週	淋巴細胞浸潤 tubulitis/vasculitis・C4d 陰性	高劑量類固醇、ATG
Acute antibody-mediated	天-週	DSA、C4d 陽性、microvasc 炎	血漿置換、IVIG、Rituximab
Chronic	月-年	間質纖維化、tubular atrophy、血管硬化	難治

- 本題：淋巴浸潤 + C4d 陰性 = **Acute cellular**

Q30 (答 C) Pellagra

- 核心知識：Niacin (B3) 缺乏 → 3D：
 - Dermatitis (光照部位粗糙、casal necklace)
 - Diarrhea
 - Dementia
- 常見族群：玉米為主食地區 (玉米中 niacin 為結合型不易吸收)、酗酒、Carcinoid syndrome (色胺酸被轉作 serotonin)

Q31 (答 A) MI 3 小時肉眼變化

- 核心知識：MI 病理時間軸

時間	肉眼	顯微
0-4h	無變化	無變化 (電顯可見)
4-12h	黑暗色	early coagulative necrosis、wavy fiber
12-24h	大理石樣	完整 coagulative necrosis、early PMN
1-3d	黃色軟化 (中央)	PMN 浸潤
3-7d	中央黃褐、邊緣紅褐	Macrophage 清除
1-2w	凹陷紅灰色	肉芽組織
> 2w	灰白堅硬瘢痕	膠原沉積

- 3 小時 → 答案 (A) 看不出變化 (顯微才能看到 early changes)

Q32 (答 D) CHF 水腫機轉

- 核心知識：水腫 4 大機轉

機轉	例子
↑ 靜水壓	CHF、深部靜脈栓塞
↓ 滲透壓 (osmotic)	肝硬化、腎病、營養不良
淋巴阻塞	乳癌術後、絲蟲
↑ 通透性	發炎、過敏

- CHF 主要機轉是靜水壓升高，不是滲透壓下降

Q33 (答 A) Giant cell arteritis

- **核心知識**：GCA = 老年人 (> 50 歲，常 > 70)、大中血管、頭部為主 (顱動脈、眼動脈)
- **病理**：granulomatous + 多核巨細胞 + IEL 斷裂
- **併發症**：失明 (眼動脈分支阻塞，急症需立即類固醇)
- **對比**：
 - Polyarteritis nodosa → 中血管、腎/腸繫膜
 - Takayasu → 大血管、主動脈弓、年輕女性
 - Kawasaki → 小孩、冠狀動脈瘤

Q34 (答 C) IDA 實驗值

- **核心知識**：IDA 五大實驗值

項目	變化
Hct、Hb	↓
MCV	↓ (microcytic)
MCHC	↓ (hypochromic)
Serum iron	↓
TIBC	↑
Ferritin	↓
轉鐵蛋白飽和度	↓
- **對比 anemia of chronic disease**：Ferritin ↑、TIBC ↓

Q35 (答 D) G6PD 缺乏症

- **核心知識**：X-linked recessive (男性多)
- **病生**：缺 G6PD → NADPH ↓ → glutathione 不能還原 → 紅血球抗氧化能力 ↓
- **誘發**：fava beans、antimalarials、sulfa 藥
- **鏡下**：Heinz body、bite cell

Q36 (答 D) Celiac disease

- **核心知識**：Celiac disease 相關淋巴瘤 = Enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL)，非 B 細胞
- **其他重點**：HLA-DQ2/DQ8、上皮內淋巴球 ↑、絨毛萎縮、隱窩增生
- **抗體**：Anti-tissue transglutaminase (tTG)、anti-endomysial
- **治療**：終身無麩質飲食

Q37 (答 A) HGSC 基因突變

- **核心知識**：High-grade serous ovarian Ca = TP53 突變 > 96%
- **衍生**：BRCA1/2 mutation 是另一重要群 (占 20%)
- **形態**：psammoma body、SET pattern、輸卵管 fimbrial origin (STIC)
- **治療意義**：BRCA+ 適用 PARP inhibitor

Q38 (答 B) MSA α -synuclein

- 核心知識：MSA = α -syn 包涵體位於 **oligodendrocyte** (GCI = glial cytoplasmic inclusion)
- 重要對比：

疾病	α -syn 包涵體位置
PD、DLB 神經元 (Lewy body)	
MSA	Oligodendrocyte (GCI)
- 臨床：MSA = parkinsonism + autonomic dysfunction + cerebellar ataxia 混合

Q39 (答 D) RA 與 TNF

- 核心知識：TNF- α 是 RA pannus 形成的關鍵 cytokine
- 拮抗劑：Infliximab、Etanercept、Adalimumab
- 其他 RA 治療靶點：
 - IL-6 $\rightarrow$ Tocilizumab
 - CTLA4-Ig $\rightarrow$ Abatacept
 - CD20 $\rightarrow$ Rituximab
 - JAK $\rightarrow$ Tofacitinib

Q40 (答 D) Pulmonary HTN 錯誤敘述

- 核心知識：**Plexiform lesion** = 晚期 PAH 病理特徵 (不是早期)
- 早期：medial hypertrophy、intimal proliferation
- 中期：concentric intimal fibrosis
- 晚期：**plexiform lesion**、necrotizing arteritis
- WHO 分類 PAH 5 群：(1) 特發/遺傳/藥物 (2) 左心病變 (3) 肺病/缺氧 (4) PE (5) 多因素

Q41 (答 B) 大葉性肺炎分期

- 正確順序：congestion $\rightarrow$ red hepatization $\rightarrow$ gray hepatization $\rightarrow$ resolution
 - Congestion：充血、漿液性滲出
 - Red hepatization：RBC + neutrophil + fibrin 滿肺泡
 - Gray hepatization：RBC 溶解、PMN 持續、fibrin 為主
 - Resolution：吞噬清除、結構恢復
- 題目把 gray 和 red 順序顛倒 = 錯
- 常見病原：S. pneumoniae (大葉性) vs S. aureus/H. influenzae/Mycoplasma (支氣管性)

Q42 (答 D) 支氣管擴張症症狀

- 核心知識：支擴常見 = 慢性咳嗽 + 大量膿痰 + 咳血 + 杵狀指
- 過度換氣 (hyperventilation) 是焦慮症狀，非典型支擴症狀
- 病因：CF、Kartagener、結核、ABPA、麻疹/百日咳後遺、IgG/IgA 缺乏

Q43 (答 D) 自體免疫肝炎

- 核心知識：自免肝炎血清 = **IgG** ↑ (不是 IgM)
- IgM 升高 → primary biliary cholangitis (PBC)
- AIH 分型：
 - Type 1：ANA、ASMA → 成人女性、HLA-DR3/DR4
 - Type 2：LKM-1、LC1 → 兒童
- 治療：類固醇 ± azathioprine

Q44 (答 B) UC 錯誤敘述

- 核心知識：UC = 僅累及結腸與直腸 (不包括 ileum) ；發炎僅限黏膜層
- "backwash ileitis" (嚴重 UC 偶爾累及末端 ileum) ≠ "涉及 ileum"
- 重要對比 UC vs Crohn：

特徵	UC	Crohn
位置	結腸 + 直腸	末端迴腸最常見，任何處
連續性	連續	skip lesion
深度	mucosa	transmural
肉芽腫	無	有 (30%)
假息肉	常見	罕見
瘻管	罕見	常見
結腸 Ca 風險	↑ ↑	↑
p-ANCA / ASCA	p-ANCA+	ASCA+

Q45 (答 B) ACTH-independent Cushing

- 核心知識：
 - ACTH-dependent (80%)：垂體腺瘤 (Cushing disease) 、ectopic ACTH (SCLC、carcinoid)
 - ACTH-independent (20%)：腎上腺腺瘤 > 增生 > 腺癌
- 診斷流程：24h cortisol → ACTH 測定 → MRI/CT
- 形態：腎上腺單側腫大 (腺瘤) vs 雙側 (hyperplasia)

Q46 (答 B) FSGS

- 核心知識：原發性 FSGS 從 juxtamedullary 腎絲球先病變
- 兒童腎病症候群最常見 = **Minimal change disease** (不是 FSGS ；成人 FSGS 較常見)
- 類固醇反應：FSGS 不佳 (Minimal change 反應極佳)
- EM：足細胞 foot process 廣泛融合 (類似 MCD) + 節段性硬化、玻璃樣變

Q47 (答 A) 橋本氏甲狀腺炎

- 核心知識：anti-TPO + anti-thyroglobulin (≥ 90% 患者陽性)

- 病理：lymphocyte 浸潤、germinal center、Hürthle cell (eosinophilic 變性的甲狀腺濾泡細胞)
- 臨床：起初可能短暫 thyrotoxicosis → 後期 hypothyroidism
- 併發：MALT lymphoma 風險 ↑

Q48 (答 A) Papillary DCIS vs Papilloma

- 核心知識：兩者都有 papilla，但 papilloma 保有肌上皮，DCIS 無肌上皮
- IHC：p63、SMA、calponin → 標記肌上皮
- 教學重點：「有 myoepithelium = 良性」是乳房病理鐵則

Q49 (答 A) 侵犯性乳癌 ER/PR/HER2 組合

- 核心知識：四大分子分型

分型	比例	治療
Luminal A：ER+/PR+/HER2- (Ki67 低)	最多 ~50%	內分泌治療為主
Luminal B：ER+/PR+/HER2± (Ki67 高)	~15-20%	內分泌 + 化療 ± HER2 標靶
HER2-enriched：ER-/PR-/HER2+	~10-15%	Trastuzumab 等 HER2 標靶
Triple negative：ER-/PR-/HER2-	~15-20%	化療為主、近年免疫療法

Q50 (答 C) Duret hemorrhage

- 核心知識：Duret hemorrhage = transtentorial (uncal) herniation → 下行性壓迫 brainstem → midbrain/pons 中央線性出血
- 其他疝出：
 - Subfalcine (cingulate)：扣帶迴在大腦鎌下，可能壓 ACA
 - Transtentorial (uncal)：顳葉鉤回，壓 CN III、PCA、brainstem (Duret)
 - Tonsillar：小腦扁桃體 → foramen magnum，壓延髓 → 呼吸停止

計分與分析建議

分數	評估	建議行動
≥ 80 分 (≥ 40 對)	卓越	加強冷門考點 + WHO 新版分類
70-79 分 (35-39 對)	達標	補強錯題系統 + 多做 buzzword 認知
60-69 分 (30-34 對)	勉強過關	系統性回看五大系統高頻疾病
50-59 分 (25-29 對)	不及格	從基礎重新建構 (Robbins 9 大章節)
< 50 分	嚴重不足	重新從基本病理學概念開始

錯題分類本範本

題號	系統	主題	錯誤類型	對應教材章節
Qx	(系統)	(疾病)	概念錯/粗心/沒看過	Robbins Ch X